EDN · RÉVISION MÉDICALE

MPR

Révision médicale complète · 7 chapitres · 12 illustrations

EDN

Informations

EDN — MPR

© 2026 EDN. Tous droits réservés.

Document de révision destiné à l'usage personnel des étudiants en médecine. Ce document n'est pas un avis médical et ne remplace aucun enseignement universitaire ni le référentiel officiel.

Source : documentation de révision EDN mise à disposition publiquement.

Langue : français. Format : EPUB 3.

Les tableaux de la source ont été convertis en texte : le libellé de chaque ligne est repris tel quel, et chaque colonne est nommée. Aucune donnée n'a été ajoutée, supprimée ni réordonnée.

Navigation : la table des matières de la liseuse donne accès à chaque chapitre. Les sections encadrées sont repliables d'un toucher.

Sommaire

Références

1	Complications du décubitus (120)
2	Techniques de rééducation et de réadaptation (122)
3	Thérapeutiques non médicamenteuses, Dispositifs médicaux (328)
4	Personne handicapée (118)
5	Enfant handicapé (56)
6	Handicap psychique (121)

Références

www.cofemer.fr

Complications du décubitus (120)

Causes du syndrome d'immobilisation

Pathologie musculosquelettique. Arthrose, complication de l'ostéoporose (fracture du col du fémur, fractures vertébrales), hallux valgus, arthrite, chute à répétition

Pathologie neurologique. AVC, neuropathies, Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie à corps de Lewy…

Pathologie cardiovasculaire. Insuffisance cardiaque, syndrome coronarien aigu, hypotension orthostatique

Pathologie pulmonaire. Pneumopathie aiguë, insuffisance respiratoire

Facteurs sensoriels. Cécité

Pathologie psychiatrique. Dépression, anxiété, délire de persécution, peur de tomber

Facteurs environnementaux et sociaux. Contention physique, iatrogénie hospitalière (sonde urinaire, perfusions, recours inapproprié aux ridelles…), manque d'aide humaine, ergonomie inadaptée, maltraitance

Douleurs aiguës ou chroniques. Plaie, maladie cancéreuse, pathologie viscérale aiguë, douleur neurogène

Iatrogénie médicamenteuse. Psychotropes, traitement favorisant le risque de chute et la peur de tomber

Autres. Dépression, sarcopénie, cachexie, dénutrition sévère, déconditionnement après alitement prolongé, pathologie somatique aiguë, situations post-chirurgicales…

Définitions immobilisation

- Soit Alitement de **> 3 jours**
- Soit Incapacité à réaliser les transferts lit-fauteuil ou à se mouvoir

Épidémio.

- Proportion des patients qui ont > 60 ans parmi les patients alités : **90%**
- Proportion des sujets de > 85 ans incapables de se mouvoir seul : **5-10%**
- Proportion des résidents d'EHPAD qui restent au lit ou au fauteuil toute la journée : **40%**
- Perte de la mobilité à domicile : **3-4%/an** (ce taux augmente rapidement chez les plus âgé)

Âge

Conséquence de l'alitement ne sont pas spécifique de la personne âgée, mais sont :

- **plus précoces**, **plus fréquentes**, **plus graves chez la personne âgée**

Complications cutanées de l'immobilisation : Escarres

Localisations des escarres

> **Pressions sont plus élevés en regard des proéminences osseuses à l'interface os/muscle**

Images